

CAPÍTULO 7.11

Nódulo Tiroideo

PERFIL EUNACOM 1.03.2.010

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Nódulo Tiroideo — Algoritmo Diagnóstico

Epidemiología

- Muy frecuente (palpable ~5%; ecográfico hasta 70%)
- La gran pregunta: ¿es benigno o maligno?
- Solo ~5-10% son malignos

Algoritmo Diagnóstico

''' Nódulo tiroideo detectado | — TSH ↓ → Gammagrafía tiroidea |
| — Nódulo caliente → Benigno → Tratar **hipertiroidismo** | —
Nódulo frío/tibio → Ecografía + PAAF | — TSH normal o ↑ —
Ecografía tiroidea (TI-RADS) | — TI-RADS 1-3 → Observar (benigno)
| — TI-RADS 4 → PAAF (biopsia) | — TI-RADS 5 → PAAF (alta
sospecha maligno) '''

Clasificación TI-RADS (ecográfica)

TABLA 7.11.1: CATEGORÍA VS PROBABILIDAD MALIGNIDAD		
CATEGORÍA	PROBABILIDAD MALIGNIDAD	CONDUCTA
TI-RADS 1	0%	Solo observar
TI-RADS 2	< 2%	Solo observar
TI-RADS 3	< 5%	Seguimiento o PAAF > 2,5 cm
TI-RADS 4	5-80%	PAAF
TI-RADS 5	> 80%	PAAF

Características ecográficas de sospecha maligna

- Hipoecogenicidad marcada
- Márgenes irregulares
- Microcalcificaciones
- Más alto que ancho
- Extensión extracapsular

Gammagrafía: ¿Cuándo se pide?

- Solo si TSH está **baja** (hipertiroidismo) → hay nódulo autónomo

- Nódulo **caliente** (hipercaptante) = benigno (hiperfuncionante)
- Nódulo **frío** (hipocaptante) = mayor riesgo de malignidad → agregar ecografía + PAAF

PERLA CLÍNICA EUNACOM

La gammagrafía NO es el primer examen. Se pide solo si hay hipertiroidismo para buscar el nódulo tóxico.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 48 años asintomático se realiza ecografía cervical por estudio de carótidas que identifica incidentalmente un nódulo tiroideo en lóbulo derecho de 18 mm, sólido, marcadamente hipoecogénico, con microcalcificaciones y bordes irregulares (TIRADS 5). TSH sérica normal (1.8 mUI/L)."

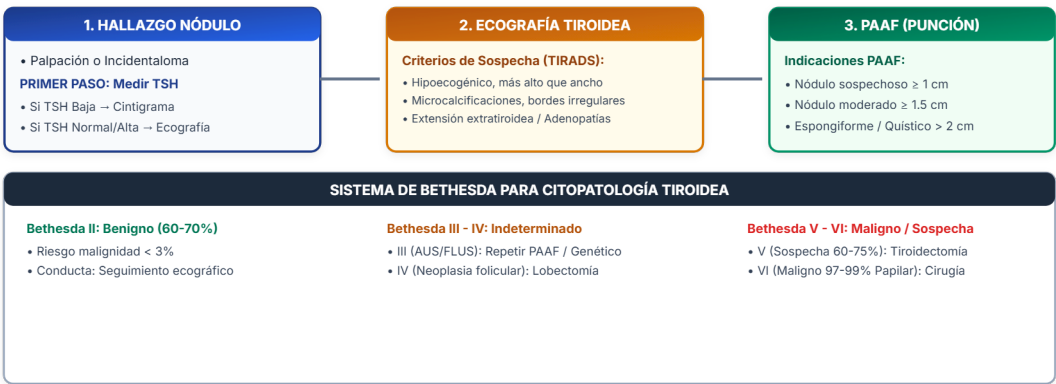
EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Nódulo Tiroideo Sospechoso: el primer paso siempre es medir TSH. Si la TSH es normal o alta, se evalúa el riesgo ecográfico (TIRADS). Con nódulo ≥ 10 mm y características ecográficas de alta sospecha (TIRADS 5: microcalcificaciones, hipoecogenicidad, más alto que ancho), la conducta obligada es Punción Aspirativa con Aguja Fina (PAAF) guiada por ecografía para estudio citológico (Sistema Bethesda).

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Estudio del nódulo tiroideo: TSH + ecografía. Si TSH suprimida → cintigrafía.
- Nódulo caliente en cintigrafía = adenoma tóxico. Nódulo frío = hacer PAAF.
- TI-RADS 1-2: no puncionar. TI-RADS 3-5 con >10 mm: PAAF.
- TI-RADS 5 (altamente sospechoso): PAAF siempre.
- La biopsia tiroidea es citológica con aguja fina (PAAF), no histológica.
- Bocio nodular se maneja igual que nódulo tiroideo.

FIGURA 7.11: ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE NÓDULO TIROIDEO Y SISTEMA BETHESDA



EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (NÓDULO TIROIDEO)

PREGUNTA 1

Paciente con nódulo tiroideo palpable. TSH 0,05 mU/L (suprimida). ¿Cuál es el siguiente paso?

- A)** PAAF del nódulo
- B)** Cintigrafía con yodo radioactivo
- C)** Tiroidectomía directa
- D)** Observar y controlar en 6 meses
- E)** Iniciar levotiroxina supresiva

RESUMEN: NÓDULO TIROIDEO

El nódulo tiroideo es frecuente y su importancia radica en descartar cáncer de tiroides y adenoma tóxico. Se estudia con TSH + ecografía. Si TSH suprimida (sospecha de hipertiroidismo): cintigrafía con yodo radioactivo. Nódulo caliente = adenoma tóxico (tratar hipertiroidismo). Nódulo frío = hacer PAAF. Si TSH normal: evaluar aspecto ecográfico con TI-RADS (1-5). TI-RADS 1 = tiroides normal. TI-RADS 2 = benigno (quiste simple, no puncionar). TI-RADS 3-4 = PAAF si >10 mm. TI-RADS 5 = altamente sospechoso, PAAF siempre (difícil si <5 mm). La biopsia es citológica con aguja fina (no histológica).